

Notes du cours du 11/04/2025

Introduction : L'hôpital, une communauté humaine complexe

L'hôpital est fréquemment le premier employeur d'une ville, comme c'est le cas pour l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP). Il constitue ainsi une grande communauté humaine regroupant de multiples professions.

I. Les Acteurs de la Communauté Hospitalière

L'hôpital rassemble différentes catégories de personnel aux statuts et fonctions variés :

A. Le Personnel Médical

- **Statut Principal** : Les médecins hospitaliers ont majoritairement le statut de **Praticien Hospitalier (PH)**. Il s'agit d'un corps spécifique de la fonction publique hospitalière, comparable à d'autres corps d'État (ex: douanes).
- **Recrutement et Carrière** : Bien que minoritaires, des médecins contractuels existent. Les carrières débutent souvent par une période contractuelle avant une éventuelle titularisation dans le corps national des PH.
- **Réglementation Nationale** : Les règles régissant les PH (rémunération, avancement, etc.) sont fixées par des textes réglementaires nationaux et non par l'hôpital lui-même. C'est un point important pour comprendre les dynamiques internes.
- **Hiérarchie Universitaire (pour les CHU)** : Inclut les statuts de Maître de Conférences des Universités - Praticien Hospitalier (MCU-PH) et Professeur des Universités - Praticien Hospitalier (PU-PH).

B. Le Personnel Non Médical (PNM)

- **Composition** : Regroupe une grande diversité de métiers : infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, manipulateurs en électroradiologie médicale, aides-soignants, personnels administratifs, personnels techniques, etc.
- **Dénomination "PNM"** : Cette appellation officielle tend à renforcer la perception de deux mondes distincts au sein de l'hôpital : ceux qui soignent (médicaux) et les autres. Cette division n'est pas seulement symbolique, elle est fortement ressentie.
- **Sous-ensemble Paramédical** : Comprend les professions de soins (infirmiers, aides-soignants, etc.).
- **Autres Personnels** : Inclut les fonctions support similaires à d'autres entreprises (informaticiens, logisticiens, etc.).

C. La Direction Hospitalière

- **Fonction** : Les Directeurs d'Hôpital assurent des fonctions d'encadrement supérieur. Ce titre ne désigne pas uniquement le directeur général de l'établissement (il y a environ 250 directeurs d'hôpital au sein de l'AP-HP, par exemple, occupant diverses fonctions de direction).
- **Corps Spécifique** : Il s'agit également d'un corps de la fonction publique. Martin Hirsch note une forte **endogamie** dans ce corps en France, se mélangeant peu avec les autres professions hospitalières, une situation moins fréquente dans d'autres pays.

D. Les Patients

Bien qu'ils ne soient pas des employés, les patients font partie intégrante de la communauté hospitalière et, comme nous le verrons, leur place dans la gouvernance évolue. L'hôpital est responsable du patient dès son entrée dans l'enceinte.

II. Typologie et Organisation des Hôpitaux

A. Statuts des Établissements

- **Hôpitaux Publics** : Généraux et Universitaires (CHU). Ils représentent environ **2/3 de la capacité hospitalière** nationale. Ce sont des établissements publics administratifs, souvent dotés d'un conseil d'administration (ou conseil de surveillance).
- **Hôpitaux Privés à But Non Lucratif** : Exemples : Institut Curie, la quasi-totalité des centres anti-cancéreux (CLCC). Sont parfois désignés sous le terme "ESPIC" (Établissement de Santé Privé d'Intérêt Collectif).
- **Hôpitaux Privés à But Lucratif** : Communément appelés **cliniques**.
- **Répartition de la Capacité** : Les secteurs privé non lucratif et lucratif représentent ensemble environ **1/3 de la capacité**.
- Il y a aussi les hôpitaux militaires mais je ne sais s'ils sont compris dans ceux du dessus ou s'ils sont à part.

B. Cas Particulier des Hôpitaux Universitaires (CHU)

- **Nombre** : Une trentaine en France.
- **Rôle Spécifique** : Ce sont les seuls lieux où se déroulent les **essais cliniques**. Un nouveau traitement a donc plus de chances d'être disponible en CHU que dans un hôpital général. Ils disposent souvent d'**équipements de pointe** (ex: IRM à haut champ, type 4 Tesla contre 1 Tesla plus courant).
- **Exemple de Taille** : L'AP-HP est le plus gros ensemble hospitalier, représentant environ **10% de la capacité hospitalière** française. La Pitié-Salpêtrière est (selon M. Hirsch) le plus grand hôpital sur un site unique en France (800 à 1000 lits), tandis que les hôpitaux de villes moyennes ont plutôt 100 à 200 lits.

C. Évolution de la Mesure de Capacité

Traditionnellement mesurée par le nombre de lits, la capacité hospitalière est de plus en plus influencée par le développement de la **chirurgie et médecine ambulatoire**. L'influence d'un chef de service était autrefois liée au nombre de lits de son service.

III. Structure Interne : Du Service au Pôle

A. La Structure Traditionnelle en Services

- Historiquement, l'hôpital était organisé en services cliniques (médecine interne, radiologie, chirurgie...) ou médico-techniques, chacun dirigé par un **Chef de Service**.

B. L'Introduction des Pôles d'Activité

- **Changement récent (15-20 ans)** : Une réforme a introduit la notion de **Pôle**, regroupant plusieurs services ou unités fonctionnelles.
- **Objectif** : Casser les "baronnies" (services fonctionnant de manière trop isolée), favoriser le travail collaboratif et l'efficacité.
- **Impact Juridique et Symbolique** : Ce changement a été vécu comme **traumatisant** par le corps médical, car le service a perdu son existence juridique obligatoire au profit des pôles et des "unités fonctionnelles" (terme technocratique désignant les services au sein des pôles).
- **Persistance Culturelle** : Malgré la réforme, la notion de "**Chef de Service**" reste extrêmement prégnante dans la culture médicale, associée à un prestige séculaire et à une pratique médicale identifiée. Le titre de "Chef de Pôle" a beaucoup moins de résonance.

C. Gradation et Spécialisation

- **Réputation** : La réputation d'un hôpital peut reposer sur l'excellence d'un service ou d'une spécialité particulière (ex: une chirurgie spécifique).
- **Niveaux de Recours** : Des tentatives existent pour **grader l'organisation hospitalière** en hôpitaux de premier, deuxième et troisième recours, reflétant les niveaux de spécialisation (ex: un hôpital général comme Dieppe ne peut réaliser de greffe cardiaque faute des services associés requis).
- **Accès aux Soins** : L'accès direct à des services très spécialisés (ex: neurologie à la Pitié-Salpêtrière, réputée en Europe) n'est pas toujours structuré en France. L'introduction de **Doctolib** à l'hôpital visait à simplifier la prise de RDV, auparavant très complexe (appels, déplacements). Cela a pu générer des problèmes initiaux (créneaux très spécialisés pris pour des motifs bénins).

IV. La Difficile Évaluation de la Qualité Hospitalière

A. Le Défi de l'Objectivation

- **Historiquement** : Il y a 30 ans, peu d'outils existaient pour évaluer la qualité d'un hôpital ou d'un service.
- **Résistance à l'Évaluation** : Les hôpitaux étaient réticents, arguant que la médecine est un art, que les services sont intrinsèquement différents et que l'évaluation externe est illégitime. (L'anecdote de la secrétaire particulière conseillant un ministre illustre une évaluation informelle basée sur la réputation).

B. Les Premiers Classements et l'Accréditation

- **Classements Médiatiques** : L'apparition de classements dans la presse (ex: L'Express) a été mal vécue mais a poussé les pouvoirs publics à réagir. Martin Hirsch relate sa propre réaction ("Comment accepter que ce soient les 'connards de l'Express' qui évaluent ?").
- **Système Officiel** : Mise en place d'un système d'**accréditation** (aujourd'hui certification par la Haute Autorité de Santé - HAS), utilisant des grilles d'évaluation sophistiquées plutôt que des notes simples.
- **Limites de l'Objectivation** : Ce système n'est pas parfait. Martin Hirsch cite l'anecdote d'un service à Cochin noté 'C' où il préférerait néanmoins aller en cas de problème, plutôt qu'un service noté 'A', illustrant la complexité et les limites de la notation formelle.

V. Enjeux de Pouvoir et Tensions à l'Hôpital

L'hôpital est un lieu de tensions et d'enjeux de pouvoir spécifiques.

A. La Hiérarchie Médico-Centrée

- **Prédominance Médicale** : Les fonctions considérées comme les plus nobles sont détenues par les médecins.
- **Plafond de Verre** : Il existe une barrière quasi-infranchissable entre les carrières médicales et non médicales. Un infirmier ne peut devenir médecin par promotion interne, contrairement à la mobilité possible dans d'autres secteurs.

B. Les Dynamiques de Genre et Sociales

- **Genre** : Historiquement, forte féminisation des postes d'aides-soignants (80%) et d'infirmiers, face à une majorité masculine chez les médecins (80% avant). Aujourd'hui, les médecins sont majoritairement des femmes, mais l'accès aux postes de direction (chef de service) reste limité (ex: 30% avant et jusqu'à 50% maintenant l'AP-HP, partant de très bas).
 - **Anecdote (Domination Implicite)** : M. Hirsch raconte l'époque où les infirmières portaient des sous-vêtements sous des blouses fines, visibles sous une lumière

forte, tandis que les médecins étaient habillés. Le passage aux pyjamas actuels a contribué à réduire cette forme de domination.

- **Ségrégation Sociale** : La ségrégation se manifeste aussi au quotidien (ex: médecins mangeant rarement à la cantine avec les infirmiers).
- **Origine Sociale** : La dimension sociale interagit avec le genre et la catégorie professionnelle.
- **Mobilité Sociale Limitée** : La possibilité de promotion sociale interne (ex: aide-soignante devenant infirmière) a diminué. M. Hirsch explique que cela coûte cher à l'hôpital : payer 3 ans de formation (salaire maintenu) + payer le remplaçant = équivalent de 6 salaires.

C. L'Affirmation du Personnel Paramédical

- **Luttes Sociales** : Des grèves importantes d'infirmières (jusqu'aux canons à eau face au ministère) ont abouti à des avancées statutaires.
- **Reconnaissance** : Obtention de l'intégration en **catégorie A** de la fonction publique et création d'une **Direction des Soins Infirmiers (aujourd'hui Direction des Soins)**, donnant une autonomie et une hiérarchie propre aux paramédicaux.
- **Professions Médicales vs Paramédicales** : La distinction se fait notamment sur le **droit de prescription**, bien que cela évolue avec les **infirmières en pratique avancée (IPA)**. (Note sur les sages-femmes : études de 5 ans en France, volonté de passer à 6 pour reconnaissance statutaire vs 3 ans en Australie).
- **Impact sur la Gestion** : La désignation des cadres soignants (anciennement "surveillantes") relève désormais de la Direction des Soins et non plus du médecin chef de service. Cela a créé des tensions, le médecin ne pouvant plus choisir entièrement son équipe, complexifiant la gestion RH. M. Hirsch suggère que l'ancien système n'était pas forcément meilleur, mais que l'organisation actuelle peut se retourner contre ceux qu'elle devait servir.

D. Le Modèle de Gouvernance

- **Choix Français** : La France a majoritairement opté pour une **direction administrative** de l'hôpital, contrairement à d'autres pays.
 - **Rationalité** : Permettre au médecin de se concentrer sur la stratégie de soins; éviter qu'un médecin-gestionnaire ne privilégie sa spécialité; considérer que les compétences médicales et de gestion ne coïncident pas toujours; la direction administrative est vue comme plus neutre.
- **Instances Représentatives** :
 - **Commission Médicale d'Établissement (CME)** : Représente les médecins, consultation obligatoire sur les grands choix. Son avis est très rarement ignoré.
 - **Comité Social d'Établissement (CSE)** : Représente les personnels non médicaux (instance issue de la fusion d'anciennes instances comme le CTE et le CHSCT). Son avis peut être plus facilement contourné.

- **Asymétrie d'influence** : Le corps médical conserve une influence prépondérante.
- **Expérience COVID** : La crise a temporairement aboli ces structures au profit d'une organisation de crise ("sauve qui peut"). M. Hirsch a proposé ensuite une **négociation tripartite** (direction, médecins, autres personnels) pour repenser le projet social et les organisations de travail, reconnaissant leur importance cruciale.

E. Tensions Budgétaires et Organisationnelles

- **Besoin Illimité vs Budget Limité** : Tension fondamentale entre le désir d'offrir le meilleur (équipements, temps, personnel) pour chaque patient et les contraintes budgétaires. Personne n'accepte l'idée de soins "dégradés". (Ex: traitements coûtant jusqu'à 2 millions d'euros; un appareil de radiothérapie stéréotaxique à 10 millions ne peut être déployé partout).
- **Organisation du Travail** : Enjeux majeurs de pouvoir :
 - **Répartition des Effectifs** : La pénurie de soignants exacerbe les tensions liées au manque de budget. (Ex: appareil stéréotaxique sous-utilisé l'après-midi faute de manipulateur radio volontaire).
 - **Horaires de Travail** : Difficulté à pourvoir certains horaires (ex: après-midi 13h-19h payé comme le matin). M. Hirsch cite un exemple où il a dû contourner la réglementation (prime d'encadrement "déguisée" + jour de congé) pour assurer le fonctionnement.
 - **Gardes et Nuits** : Inversement de la tendance : il y a 20 ans, forte demande pour les nuits; aujourd'hui, difficulté à les pourvoir (faible attractivité financière : ex: garde de 12h le WE payée 240€, jugée moins rentable que d'autres activités par certains médecins). Le **Sécur de la Santé** a tenté de répondre (500M€) mais sans satisfaire toutes les demandes (gardes, nuits).

F. Rigidité du Cadre et Impuissance Locale

- **Cadre Rigide** : Salaires fixés nationalement (statut), peu de marge de manœuvre locale sur les affectations, l'organisation (pôles, services, commissions réglementées - loi Rist récente assouplissant un peu mais avec des verrous).
- **Conséquences** : Sentiment d'impuissance locale face aux problèmes, conduisant à des stratégies de contournement ("fuite") ou à des "explosions/implosions" (désertion, pénurie, manque de personnel).
- **Paradoxe** : L'hôpital est un employeur majeur mais dispose de peu de leviers locaux pour agir sur les facteurs clés (salaires, organisation...).
- **Exemple du Logement à l'AP-HP** :
 - Parc de 7000 logements pour 100 000 agents (dont 30k infirmières, 25k aides-soignantes).
 - Turnover permettant d'affecter 300-350 logements/an pour une demande 15 fois supérieure. (M. Hirsch a pu augmenter à 400 via construction, mais insuffisant).

- **Aberration** (selon M. Hirsch) : 250 logements réservés aux 250 directeurs d'hôpital (héritage historique + occupation par des unités INSERM). Il a réussi à négocier l'échange de grands logements parisiens de directeurs contre 300 logements plus petits en proche couronne pour les infirmières.

G. Délégation aux Pôles et Réticences Médicales

- **Problème de la Délégation** : La délégation de pouvoir (et de gestion) vers les pôles a posé problème aux médecins :
 - Réticence à arbitrer entre confrères (ex: attribution d'infirmières supplémentaires).
 - Réticence à gérer des aspects matériels (ex: travaux de peinture) après de longues études médicales (jusqu'à HDR).
 - Volonté d'avoir le pouvoir de dire "oui" mais pas celui de dire "non".
- **Nomination d'un Adjoint Médecin** : M. Hirsch relate sa tentative initiale de nommer un médecin comme numéro 2, refusée par les directeurs et les médecins eux-mêmes ("Qui êtes-vous pour décider ?"). Après le COVID, il a pu nommer une femme, cheffe de pôle anesthésie très impliquée pendant la crise, comme directrice adjointe (gestion des stocks...). Son étonnement face à la "sympathie" de M. Hirsch envers les médecins a révélé la profondeur de leur refus d'être dirigés par un pair.
- **Proposition de Gouvernance Mixte** : M. Hirsch plaide pour une direction collégiale mixte (Directeur d'hôpital, chef de pôle, cadre infirmier en chef...) avec une instance de décision tournante, comme cela se fait dans d'autres pays.

VI. Vers une Démocratie Sanitaire : La Place des Patients

A. L'Introduction des Patients dans la Gouvernance

- **Catalyseur COVID** : Pendant la crise, M. Hirsch a inclus des représentants des patients dans les réunions de crise quotidiennes. Leur contribution a été jugée pertinente (prise en compte d'autres catégories de patients, etc.).
- **Institutionnalisation** : Constatant la valeur ajoutée de cette présence ("corps étranger" positif), il a œuvré pour pérenniser cette inclusion.
- **Loi de 2021** : La loi permet désormais l'introduction de représentants des patients dans les **directoires** des hôpitaux (l'instance de direction exécutive). Cela fait du patient une partie prenante à part entière.

B. Sélection des Représentants des Patients

- **Origine** : Choisis au sein d'**associations de patients** agréées. (Environ 150 représentants pour les 38 hôpitaux de l'AP-HP).
- **Processus de Sélection (pour le Directoire)** : Appel à candidatures, auditions menées par M. Hirsch lui-même, puis choix final (similaire à un processus de recrutement).

- **Enjeu Démocratique Fondamental** : La présence du patient au cœur des instances de décision est vue comme essentielle pour la démocratie sanitaire.
-